

Sformułowanie *przypadku*

Rozszerzenie diagramu o diagnozę, czynniki podatności i plan terapii. Żywy dokument kliniczny — do pracy z klientem, superwizji i przekazania zespołowi. Budowany wspólnie, nie stawiany nad klientem.

CZAS: 60 min · poziom zaawansowany Po 4–6 sesjach, jako podsumowanie fazy diagnostycznej

ŹRÓDŁO: Persons (2008); Kuyken i in. (2009)

JAK UŻYWAĆ

Tworzysz pisemny dokument (3–5 stron) integrujący całość pracy: **problemy, mechanizmy podtrzymujące, hipotezę o przekonaniu kluczowym, czynniki podatności, wyzwalacze i plan terapii**. To rozszerzenie diagramu konceptualizacji o komponenty diagnostyczne, historyczne i strategiczne (ang. *case formulation*). Budujesz go wspólnie z klientem, dzielisz się nim i używasz w superwizji; aktualizujesz co 3–5 sesji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Bez dokumentu integrującego informacje pozostają w rozproszonych notatkach — trudno wrócić do całościowej hipotezy w połowie terapii, a zmiana terapeuty oznacza utratę konceptualizacji. Wspólne formułowanie (ang. *collaborative case conceptualization*) zwiększa trzy rzeczy naraz: trafność empiryczną, sojusz i zaangażowanie klienta — i odróżnia wspólną terapię poznawczo-behawioralną od „aplikowania protokołu”. Warunek: dokument musi być **żywy, nie archiwalny**, inaczej zamienia się w etykietę niepasującą do ewoluującego obrazu klienta.

01



Sześć elementów

1 · PROBLEMY

2 · HIPOTEZA O RDZENIU

3 · CZYNNIKI PODATNOŚCI

4 · WYZWALACZE

5 · MECHANIZMY PODTRZYMUJĄCE

6 · PLAN TERAPII

02 Krótka biografia i geneza rdzenia

Zwięźle: kluczowe doświadczenia formacyjne i jak uformowały hipotetyczny rdzeń. To kontekst, nie pełna historia życia.

BIOGRAFIA → GENEZA RDZENIA

03 Plan terapii i pomiar

Jakie techniki dla tego rdzenia, w jakiej kolejności, jak mierzysz postęp? Powiąż z hipotezą terapeutyczną.

TECHNIKI, KOLEJNOŚĆ, MIARY POSTĘPU

04 Aktualizacja

Zaplanuj rewizję co 3–5 sesji. Zapisz datę następnej aktualizacji i co warto wtedy sprawdzić.

NASTĘPNA AKTUALIZACJA

Klucz: sformułowanie buduje się wspólnie z klientem, a nie stawia nad nim — to odróżnia terapię poznawczo-behawioralną od aplikowania protokołu. Dokument ma być żywy: aktualizuj go co 3–5 sesji w miarę napływu danych, by nie stał się etykietą niepasującą do klienta.